TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

SEPTISK CHOCK

Första timmen • Antibiotika • Uppföljning

Antibiotikabehandling bör vara insatt senast inom 60 min vid hotande, misstänkt eller konstaterad septisk chock – ej avklarad provtagning får ej förhindra detta. **Kontakta alltid infektionsläkare** vid misstanke om septisk chock. PM:et gäller även sepsis som progredierar trots initialt påbörjad behandling. Källa s. 1

01 FÖRSTA ÅTGÄRDER

Källa s. 1–2

1. **Syrgas** på mask eller grimma om saturation <93 %. Mål >93 %, men >97 % med syrgas ska undvikas. Lägre saturation bör accepteras vid KOL (risk för koldioxidretention).
2. **Två perifera venvägar** initialt, helst grön (18G) eller grövre nål.
3. **Två par blododlingar** (aerob och anaerob, slaskrör före) innan Ringer-Acetat kopplas till den ena nålen.
4. **Ringer-Acetat 500–1000 ml på <30 minuter**, övertrycksmanschett vid behov.
5. Misslyckad venväg: **intraosseös nål**. Ofta kan bara mindre mängder, 4–10 ml blod, aspireras – till 2 olika pedibact-odlingsflaskor. Antibiotika och Ringer-Acetat kan ges intraosseöst.
6. **Prover** via den andra nålen (se nedan). **Sätt urinkateter.**

02 PROVER OCH ODLINGAR

Källa s. 1–2

BLODPROVER

- CRP, blodstatus + B-celler, elektrolyter, kreatinin, bilirubin, ALAT, ALP, APT-tid, PK, P-glukos och blodgas.
- Stark misstanke om koagulopati (petekier, ekymoser eller onormal blödning): även antitrombin, fibrinogen och D-dimer.

ODLINGAR OCH TESTER

- Utan att antibiotika fördröjs: urinodling och, om tillståndet så indicerar, odlingar från andra lokaler som svalg, nasofarynx, sputum, sår och likvor.
- Strep A från hals och/eller sår vid misstanke om allvarlig mjukdelsinfektion eller invasiv streptokocksepsis.
- Luftvägssymtom: överväg storaluftvägsblocket, pneumokock- och legionellaantigen i urin samt EKG för att utesluta förlängd QTc-tid (då bör azitromycin och moxifloxacin undvikas).

TESTDOKUMENT
Sammanfattning av Kjell Stefansson – inte av PM:ets författare

TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

03 CIRKULATION – NÄR IVA?

Källa s. 1–3

FORTSATT VÄTSKA

- Systoliskt blodtryck fortfarande <90 mm Hg (eller MAP <65 mm Hg): ge ytterligare **Ringer-Acetat 500 ml/30 min** och kontakta IVA-framjouren.
- När blodtrycket stabiliserats: fortsätt med Ringer-Acetat i långsammare takt.

KONTAKTA IVA-FRAMJOUREN

- Gravt cirkulationspåverkad: kapillär återfyllnad >3 s eller blåmarmorering ovanför mitten av låret.
- Mentalt påverkad patient.
- Patienten förbättras inte avseende puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, medvetandegrad och urinproduktion.

04 EMPIRISK ANTIBIOTIKA EFTER MISSTÄNKT FOKUS

Källa s. 2–3

MISSTÄNKT FOKUS	REKOMMENDERAD BEHANDLING
Samhällsförvärvad infektion med oklart fokus/ingångsport	Cefotaxim 2 g iv + gentamicin 5–7 mg/kg iv
Luftvägar förlängd QTc: azitromycin och moxifloxacin bör undvikas (se ovan)	Cefotaxim 2 g iv med tillägg av antingen azitromycin 500 mg iv eller moxifloxacin 400 mg iv
Urinvägar hos patient utan föregående antibiotikabehandling, strukturella eller funktionella avvikelser i urinvägarna	Cefotaxim 2 g iv + gentamicin 5–7 mg/kg iv
Övriga patienter med urinvägsfokus	Piperacillin-tazobaktam 4 g iv + gentamicin 5–7 mg/kg iv
Urinvägar med ökad risk för ESBL tidigare ESBL, eller sjukvårdande behandling i eller resa till länder utanför Norden, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland inom 6 mån	Imipenem/meropenem 1 g iv
Bukorgan eller genitalia	Imipenem (övre buk) eller meropenem (nedre buk) 1 g iv som monoterapi, alternativt piperacillin-tazobaktam 4 g + gentamicin 5–7 mg/kg iv
Mjukdelsinfektion utan säker streptokocketiologi	Imipenem/meropenem 1 g iv med tillägg av klindamycin 600 mg iv
Stark misstanke om invasiv streptokocksepsis strep A positiv i sår	Bensylpenicillin 3 g iv + klindamycin 600 mg iv

Ge i normalfallet fyra–fem doser betalaktamantibiotika första dygnet; den andra dosen ges mitt i doseringsintervallet mellan första och andra dosen. Aminoglykosid ges i regel endast som en dos. Smalna av så snart odlingssvar med resistensbestämning föreligger.

Förlängd infusion på 3–4 timmar bör rekommenderas för kritiskt sjuka patienter på IVA. Överväg koncentrationsbestämning av betalaktam vid ökat renalt clearance eller uttalad njursvikt. CVVHD: underdosera inte – vanligen normaldos; följ koncentrationen av vancomycin och aminoglykosider.

Fortsatt dosering: SILF:s vårdprogram Sepsis och septisk chock, RAF:s doseringstabell och RAF:s dosrekommendationer vid njurersättningsbehandling.

TESTDOKUMENT Sammanfattning av Kjell Stefansson – inte av PM:ets författare

TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

05 FOKUS OCH ÖVERVAKNING

Källa s. 3

- Misstänkt svår mjukdelsinfektion: kontakta opererande specialitet (plastikkirurg, ortoped, ÖNH, urolog eller gynekolog beroende på lokalisation).
- Planera för dränage av abscess om sådan misstänks föreligga.
- Avstängd pyelonefrit: kontakta röntgenjouren för NP-kateterinläggning.
- Ta bort eventuell infekterad kateter.
- Följ NEWS2, initialt tätt (x 24–48); kontrollerna glesas ut efter stabilisering. Följ urinproduktionen, om möjligt timdiures. EKG vid behov.
- Förnyad bedömning efter 6 timmar inklusive ny blodgas och eventuellt koagulationsprover.

06 KORTIKOSTEROIDER OCH IMMUNGLOBULIN

Källa s. 3–4

- **Solu-Cortef 50 mg x 4** om patienten trots adekvat volymresuscitering och noradrenalindos > 0,3 mikrog/kg/tim inte når perfusionsmålen och fortfarande är i chock. Avsluta så fort chocken är hävd, trappas inte ut. Behandling med Florinef är inte indicerad.
- Står redan på glukokortikoider: dubblerad dos po vid feber >38 °C, tredubblad vid >39 °C. Vid denna indikation används hydrokortison (Solu-Cortef; 20 mg motsvarar 5 mg Prednisolon), ofta 50–100 mg som initial dos, maximal substitutionsdos 200 mg iv per dygn.
- Steroidbehandlad patient utan feber med misstänkt septisk chock: Solu-Cortef uppdelat på flera doser (max 200 mg iv dagligen); minska successivt under några dagar till underhållsdos när patienten förbättrats.
- **Intravenöst immunglobulin** vid septisk chock (eller under utveckling) och stark misstanke om streptokocketiologi: 1 g/kg x 1, eventuellt 0,5 g/kg x 1 i ytterligare två dagar så länge tillståndet progredierar.

TESTDOKUMENT
Sammanfattning av Kjell Stefansson, inte av PM:ets författare

Region Uppsala: ”Behandling och handläggning av septisk chock”.
DocPlusSTYR-10049 · version 8 · godkänt 2025-05-14.
Via akutkompassen.se/#pm=10049 · hämtat 2026-10-08.
Original-PM (DocPlus)

OM SAMMANFATTNINGEN

Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.